

Динамика показателей гуморального звена иммунной системы при консервативной терапии фибромиомы матки

Манамбаева З.А., Мукашева С.А., Жетписбаев Б.А., Апсаликов Б.А., Савхатов Д.Х.

Государственный медицинский университет г.Семей
Медицинский центр Управления делами Президента РК,
Астана Казахский НИИ онкологии и радиологии

Жатыр фибромиомасымен ауырлардың гуморалды иммунитет құрамбөлігінің динамикасына индинолом және эпигаллатом консервативті терапия зерттеулерін жүргіздік. Қолданған әдіс бойынша алынған қорытындылар иммунно жүйесінің гуморалды құрамбөлігінің динамикасының жақсарғанын көрсетті.

Нами было проведено исследование динамики гуморального звена иммунитета больных фибромиомой матки при консервативной терапии индинолом и эпигаллатом. Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике со стороны гуморального звена иммунной системы при использовании разработанного метода.

Актуальность исследования

Актуальной задачей гинекологии является органосохраняющее лечение больных миомой матки и аденомиозом. Существующая в настоящее время терапия гормональными препаратами миомы матки и аденомиоза имеет ряд существенных недостатков [1, 2]. После прекращения гормонального лечения у большинства пациенток происходит рецидив клинической симптоматики. Заслуживает также внимания выраженность побочных эффектов и большое число противопоказаний к гормональной терапии [3, 4].

В результате многочисленных исследований гормонального статуса, рецепторов гормонов при миоме матки получены неоднозначные результаты, свидетельствующие о гетерогенности миомы. В настоящее время доказана роль других, ранее неизвестных факторов в генезе сочетания миомы матки и аденомиоза, а именно: нарушения процессов апоптоза, пролиферации, неоангиогенеза, стромаобразования в развитии указанных заболеваний. В литературе описаны вещества, обладающие антипролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим действием, в частности индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат. Индол-3-карбинол обладает мощной противоопухолевой активностью, патогенетически воздействуя на основные звенья развития гиперпластических процессов в организме. Эпигаллокатехин-3-галлат — один из представителей катехинов, обладает сильнейшей антиоксидантной активностью, сопоставимой с селеном, а также противовоспалительным, антипролиферативным и антиангиоген-

ным действием [5-8]. Поэтому в настоящее время активно развиваются направления консервативной терапии, в частности, связанное с негормональным блокированием опухолевого роста. В то же время, исследований, позволяющих судить об эффективности данного подхода к лечению в различных популяциях еще явно недостаточно.

Цель исследования

- изучение влияния индинола и эпигаллата на реактивность гуморального звена иммунной системы при фибромиоме матки.

Материалы и методы

Было проведено иммунологическое исследование у 79 больных фибромиомой матки, 39 больных получали эпигаллат в сочетании с индинолом - по 2 капсулы эпигаллата и 2 капсулы индинола 2 раза в день в течение 6 месяцев. Были применены следующие методы исследования: количественное определение иммуноглобулинов методом радиальной иммунодиффузии в геле; определение циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке преципитацией полиэтиленгликолем; методы статистического анализа.

Результаты исследования

В исследованных нами двух клинических группах больных фибромиомой матки простой и пролиферирующих форм было осуществлено применение двух схем консервативной терапии.

В таблицах 1 и 2 показаны данные, характеризующие особенности показателей гуморального звена иммунной системы у обследованных больных в результате проведенного лечения.

Как в исходе, так и при проведении традиционной терапии имелись достоверные нарушения по содержанию в крови IgA (превышение над контролем на 21,5% и 17,6% соответственно, $p < 0,01$ в обоих случаях), IgM (на 14,2% и 19,6% соответственно, $p < 0,05$ в обоих случаях). Значительно было увеличено также содержание циркулирующих иммунных комплексов. Различия с контролем по данному показателю составили 67,8% и 88,0% соответственно ($p < 0,01$).

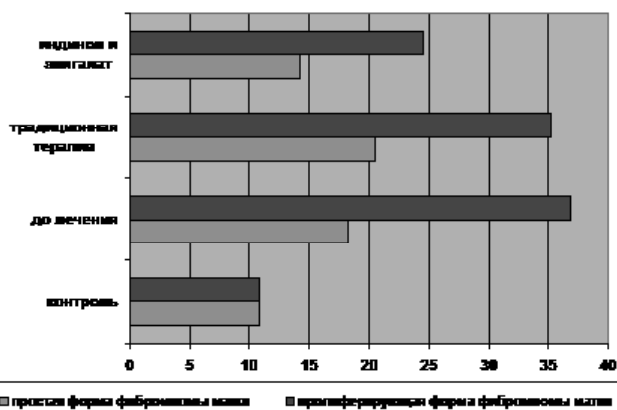


Рисунок 1 — динамика показателей концентрации ЦИК при консервативной терапии фибромиомы матки

Таблица 2 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы у больных с миомой матки в результате проведенного лечения (пролиферирующая форма)

Показатель	Контроль, n=40	Больные с миомой матки (пролиферирующая форма)		
		исход	трад. терапия, n=20	разработ. терапия, n=21
IgA, г/л	1,44±0,02	1,05±0,02**	1,13±0,02**@	1,27±0,02*@@°
IgM, г/л	1,98±0,05	1,33±0,04**	1,28±0,03**	1,69±0,04*@@°
IgG, г/л	11,74±0,66	9,75±0,63*	9,53±0,60*	10,92±0,65
ЦИК, ЕОП	10,9±0,7	36,8±2,7**	35,2±2,5**	24,6±1,5**@°

Примечания:
 * - различия с показателем контроля достоверны, $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$
 @ - различия с исходом достоверны, $p < 0,05$, @@ - $p < 0,01$
 ° - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, $p < 0,05$, °° - $p < 0,01$

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы у больных с миомой матки в результате проведенного лечения (простая форма)

Показатель	Контроль, n=40	Больные с миомой матки (простая форма)		
		исход	трад. терапия, n=20	разработ. терапия, n=21
IgA, г/л	1,44±0,02	1,75±0,03**	1,69±0,03**	1,48±0,02@°
IgM, г/л	1,98±0,05	2,26±0,06*	2,37±0,07*	2,05±0,06@°
IgG, г/л	11,74±0,66	13,05±0,77	12,93±0,80	11,90±0,77
ЦИК, ЕОП	10,9±0,7	18,3±1,2**	20,5±1,5**	14,2±1,1*@°

Примечания:
 * - различия с показателем контроля достоверны, $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$
 @ - различия с исходом достоверны, $p < 0,05$
 ° - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, $p < 0,05$

Проведение разработанной терапии обеспечило практическую нормализацию всех нарушенных показателей. Так, относительно исхода содержание IgA снизилось на 15,4% и было на 12,5% ниже, чем в случае традиционной терапии ($p < 0,05$; $p < 0,05$). Соответствующие различия увеличения IgM равнялись в среднем 9,4% и 13,5% ($p < 0,05$; $p < 0,05$). Полностью нормализовывалось содержание IgG.

При пролиферирующей форме миомы матки степень различий была куда более выраженной. Так, в исходе отмечалось снижение, а не повышение содержания иммуноглобулинов всех основных классов. Различия с контролем достигали 27,1% по IgA, 32,9% - по IgM и 17,1% - по IgG. Очень резкое превышение было отмечено по содержанию ЦИК. Оно составило в исходе 237,5% ($p < 0,01$).

При традиционной терапии достоверная динамика к нормализации была выявлена только по содержанию IgA. Различия с исходом составили 7,6% ($p < 0,05$).

При применении разработанной терапии сохранялось достоверное снижение содержания IgA и IgM. Сохранялось также резкое превышение уровня ЦИК (125,7%, $p < 0,01$). Однако тенденции к нормализации также были значительными. Превышение уровня IgA над исходом составило 21,0% ($p < 0,01$), над традиционной терапией - на 12,5% ($p < 0,05$). По уровню IgM соответствующие различия составили 27,2% и 32,0% ($p < 0,01$ в обоих случаях). Отмечалась практически полная нормализация содержания IgG, не было достоверных различий ни с контрольной группой, ни с показателями традиционного лечения.

Несмотря на наличие превышения концентрации ЦИК, их уровень снизился в сравнении с исходом на 22,4% и с традиционной терапией - на 30,8% ($p < 0,05$ в обоих случаях простой фибромиомы матки). При пролиферирующей форме фибромиомы матки степень снижения содержания ЦИК составила 33,2% к исходу и 30,1% - к группе сравнения ($p < 0,05$ в обоих случаях).

Таким образом, полученные в результате исследования результаты свидетельствуют о наличии положительной динамики показателей клеточного звена иммунитета при применении разработанной методики консервативной негормональной терапии фибромиомы матки индинолом и эпигаллатом.

Литература

1. Берштейн Л.М. Эпидемиология, патогенез и пути профилактики рака эндометрия: стабильность или эволюция? // *Практ. Онкол.* - 2004. - № 5. - С. 1-8.
2. Вдовенко И.А. Клинико-морфологическое обоснование комплексного лечения доброкачественных гиперпластических процессов в эндометрии в пременопаузе // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Челябинск, 2006. - 23 с.
3. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. Гинекология: национальное руководство. Под ред. М: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1072 с.
4. Закирова Г.Ю. Роль факторов локального иммунитета в прогрессировании гиперпластических процессов эндометрия в репродуктивном возрасте и их коррекция // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ташкент, 2007. - 19 с.
5. Киселев В.И., Ляшенко А.А. Молекулярные механизмы регуляции гиперпластических процессов. М: Димитрейд График Групп. - 2005. - 348 с.
6. Sah J.F., Balasubramanian S., Eckert R.L., Rorke E.A. Epigallocatechin-3-gallate inhibits epidermal growth factor receptor signaling pathway. Evidence for direct inhibition of ERK12 and AKT kinases // *J. Biol. Chem.* - 2004. - № 13. - P. 12755-12762.
7. Ashok B.T., Chen Y.G., Liu X. Multiple molecular targets of indole-3-carbinol, a chemopreventive anti-estrogen in breast cancer // *Eur. J. Cancer Prev.* - 2002. - № 11. - P. 86-93.
8. Пашков В.М., Лебедев В.А., Коваленко М.В. Современные представления об этиологии и патогенезе гиперпластических процессов эндометрия // *Вопросы гин. акуш. и перинатол.* - 2006. - №5. - С. 51-59.